



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày

26-07-2025

Thời gian

07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE

02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ MỤN TRÚNG CÁ TRONG MỘT SỐ RỐI LOẠN NỘI TIẾT

ThS.BSNT Nguyễn Tâm Anh

Bộ môn Da liễu, Đại học Khoa học Sức khỏe, ĐHQG-HCM



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Nội dung

Tổng quan

Nội tiết ảnh hưởng như thế nào trong mụn trứng cá ?

Cập nhật điều trị mụn trứng cá trong PCOS, AFA

Kết luận



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Tổng quan

- Mụn trứng cá là một bệnh đa yếu tố, rất phổ biến của đơn vị nang lông tuyến bã
- MTC ảnh hưởng đến khoảng 85% bệnh nhân vị thành niên và 3% bệnh nhân trưởng thành trong 35-44 tuổi.
- MTC không gây đe dọa tính mạng nhưng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, tâm lý xã hội và kinh tế cho bệnh nhân.
- Những bất thường trong chuyển hóa steroid androgen, con đường tín hiệu tế bào – tế bào và tình trạng viêm không kiểm soát dẫn đến triệu chứng lâm sàng khác nhau bao gồm MTC thông thường.

Bhate K, Williams HC. Epidemiology of acne vulgaris. Br J Dermatol. 2013;168(3):474-85



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



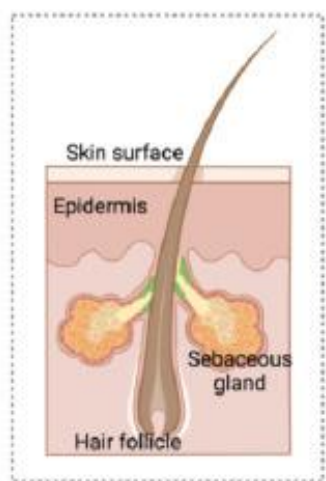
Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00

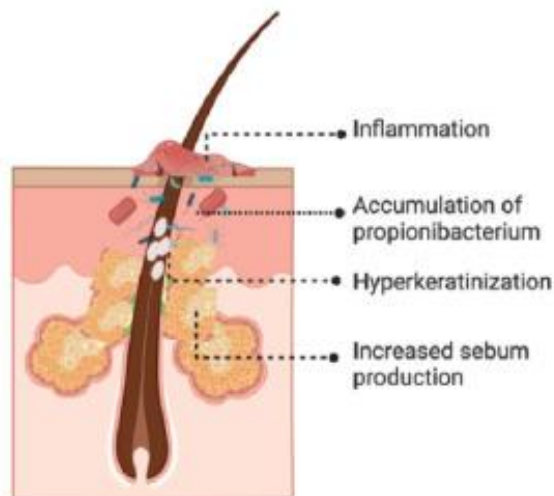
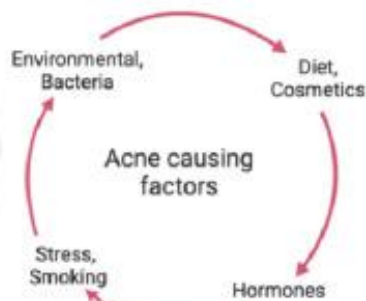


Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

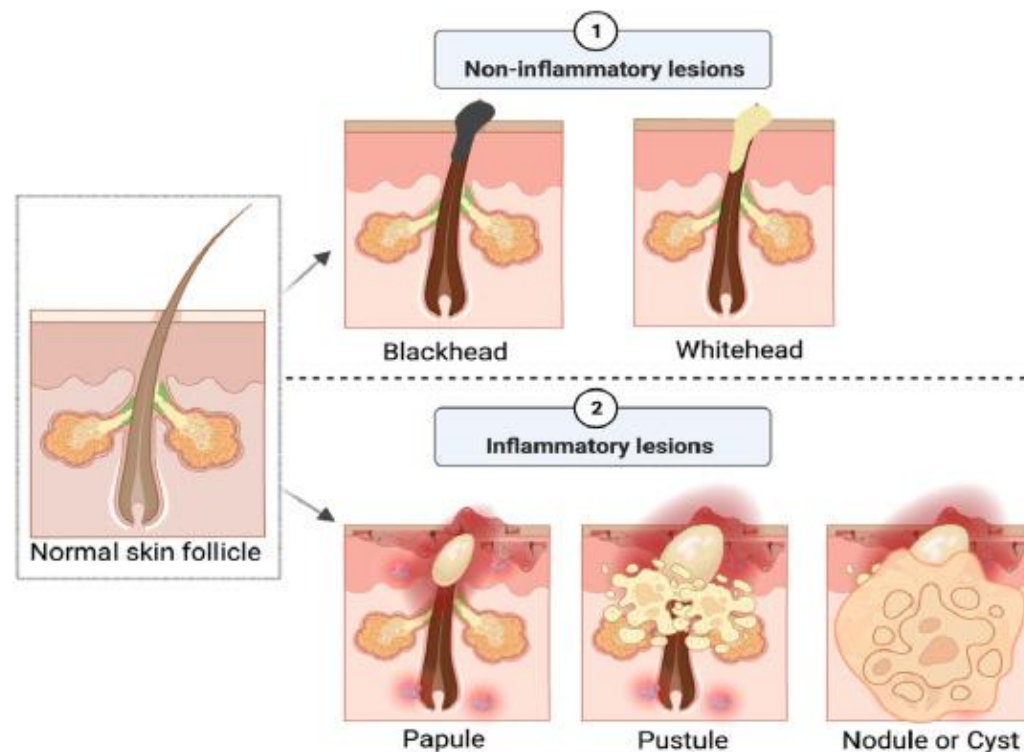
Cơ chế bệnh sinh



Healthy Skin tissue



Acne inflamed skin tissue



Vasam M, Korutla S. *Biochem Biophys Rep.* 2023;36:101578. doi:10.1016/j.bbrep.2023.101578



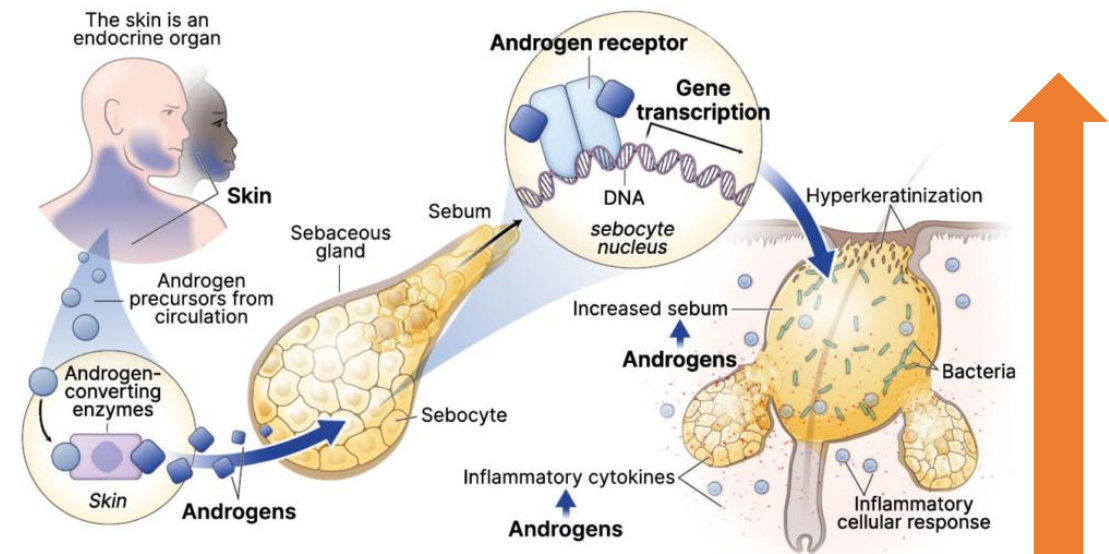
Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Mối liên quan giữa mụn trứng cá và hormon



↑ hoạt động tuyến bã
↑ sừng hóa
↑ viêm

Hormone	Tác động chính liên quan đến mụn
Testosterone	Kích thích tuyến bã, tiền chất chuyển thành DHT
DHT	Tăng hoạt động tuyến bã và sừng hóa cổ nang lông
DHEAS	Tiền chất androgen, tăng sản xuất bã tại da
CRH / ACTH	Tăng tiết androgen thượng thận, kích thích tuyến bã
Insulin	Giảm SHBG → tăng androgen tự do; tăng IGF-1
IGF-1	Kích thích tuyến bã, tăng 5α-reductase, tăng nhạy cảm androgen
Prolactin	Gián tiếp tăng androgen; rối loạn trục sinh dục
T3, T4	Rối loạn chuyển hóa nội tiết, làm tăng androgen tương đối
Estrogen	Tăng SHBG, ức chế tuyến bã và 5α-reductase



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

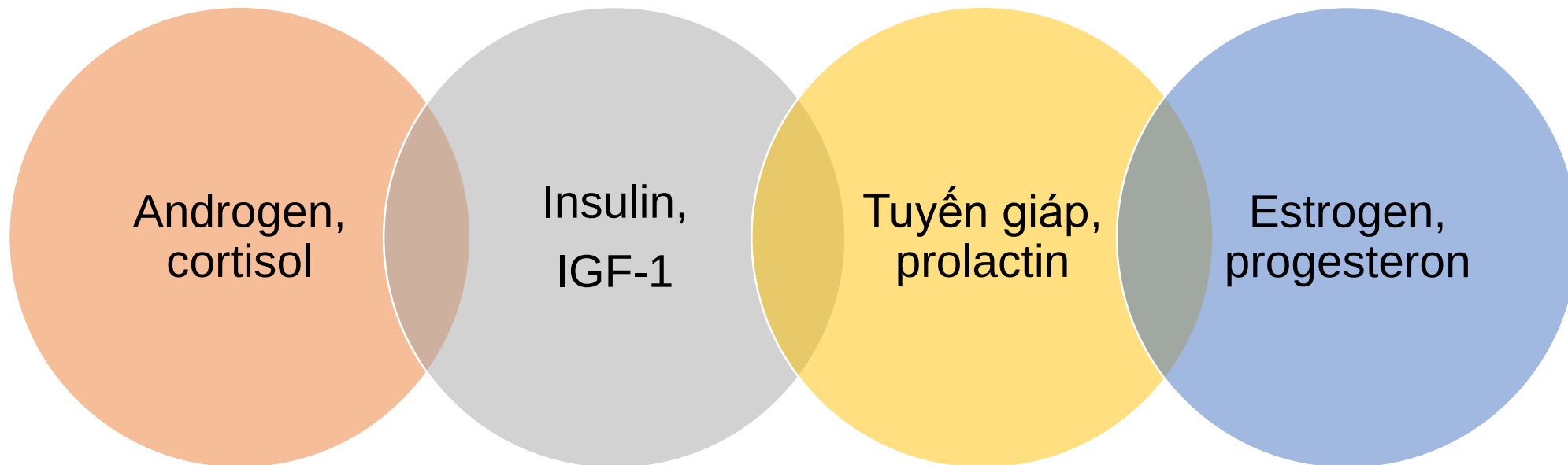
Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Một số rối loạn nội tiết ảnh hưởng đến MTC

- Hội chứng đa nang buồng trứng
- Mụn trứng cá ở phụ nữ trưởng thành
- Dây thì sớm
- Tăng sản thượng thận bẩm sinh
- U tuyến thượng thận
- Suy giáp
- Cường giáp
- Hyperprolactinemia





HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Hội chứng buồng trứng
đa nang (PCOS)

Mụn trứng cá ở phụ nữ
trưởng thành (AFA)



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày

26-07-2025

Thời gian

07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE

02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Hội chứng buồng trứng đa nang Polycystic Ovary Syndrome



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Hội chứng buồng trứng đa nang

- Hội chứng đa nang buồng trứng (PCOS) là tình trạng nhiều nang nhỏ không trưởng thành xuất hiện trên buồng trứng, có thể được phát hiện qua siêu âm gây rối loạn kinh nguyệt mãn và cường androgen, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.
- 6-20% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có thể bị PCOS
- Triệu chứng lâm sàng: **triệu chứng tăng androgen** có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch như thừa cân, béo phì, không dung nạp glucose, rối loạn lipid máu, gan nhiễm mỡ...
- Chẩn đoán theo tiêu chuẩn Rotterdam khi có **2/3 đặc điểm: chu kì kinh nguyệt không đều, tăng androgen (lâm sàng/huyết thanh), buồng trứng đa nang trên siêu âm**



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

European Journal of Endocrinology, 2023, 189, G43-G64

<https://doi.org/10.1093/ejendo/lvad096>

Advance access publication 15 August 2023

Clinical Practice Guideline



Recommendations from the 2023 international evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome

Helena J. Teede,^{1,2,*} Chau Thien Tay,^{1,2} Joop J.E. Laven,^{2,3} Anuja Dokras,⁴ Lisa J. Moran,^{1,2} Terhi T. Piltonen,⁵ Michael F. Costello,^{2,6} Jacky Boivin,⁷ Leanne M. Redman,⁸ Jacqueline A. Boyle,^{2,9} Robert J. Norman,^{2,10} Aya Mousa,¹ and Anju E. Joham^{1,2} on behalf of the International PCOS Network[†]

Step 1: Irregular cycles + clinical hyperandrogenism

(exclude other causes)* = diagnosis

Step 2: If no clinical hyperandrogenism

Test for biochemical hyperandrogenism (exclude other causes)* = diagnosis

Step 3: If ONLY irregular cycles OR hyperandrogenism

Adolescents ultrasound is not indicated = consider at risk of PCOS and reassess later

Adults - **request ultrasound for PCOM***, if positive (exclude other causes)* = diagnosis



- Rậm lông
- Mụn trứng cá
- Rụng tóc kiểu nữ

* Exclusion of other causes = TSH, prolactin, 17-OH progesterone, FSH or if clinically indicated exclude other causes (e.g. Cushing's Syndrome, adrenal tumours). For hypogonadotrophic hypogonadism, usually due to low body fat or intensive exercise, exclude clinically and with LH/ FSH. PCOM = polycystic ovarian morphology on ultrasound



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Mụn trứng cá trong PCOS

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY
2021, VOL. 37, NO. 5, 392–405
<https://doi.org/10.1080/09513590.2020.1859474>



Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

Check for updates

Prevalence of acne vulgaris among women with polycystic ovary syndrome: a systemic review and meta-analysis

Fahimeh Ramezani Tehrani^a, Samira Behboudi-Gandevani^b, Razieh Bidhendi Yarandi^a, Marzieh Saei Ghare Naz^a and Enrico Carmina^c

- Những người PCOS có tỉ lệ mắc MTC là 43%, cao hơn gấp 1,6 lần so với người khỏe mạnh
 - Tỉ lệ MTC ở thanh thiếu niên và người lớn lần lượt là 59% và 42%
 - Tỉ lệ cao nhất được báo cáo ở Đông Á, cao gấp 3,5 lần so với người không mắc PCOS
- ➔ **Mụn trứng cá là một trong những biểu hiện da liễu phổ biến PCOS**

Ramezani Tehrani, F. (2020). Prevalence of acne vulgaris among women with polycystic ovary syndrome: a systemic review and meta-analysis. *Gynecological Endocrinology*, 37(5), 392–405



Điều trị MTC trong PCOS

FDA (US)	European Society of Endocrinology	Indian Acne Association
-	Cyproterone acetate	Cyproterone acetate
Thuốc tránh thai phối hợp	Thuốc tránh thai phối hợp	Thuốc tránh thai phối hợp
Spironolactone (Off-label)	Spironolactone	Spironolactone
	Tretinoin uống	Tretinoin uống
Flutamide (Off-label)	Flutamide	Flutamide
-	Finasteride	Finasteride
-	Kháng sinh uống	Kháng sinh uống
-	Metformin	
-	-	Retinoid thoa tại chỗ



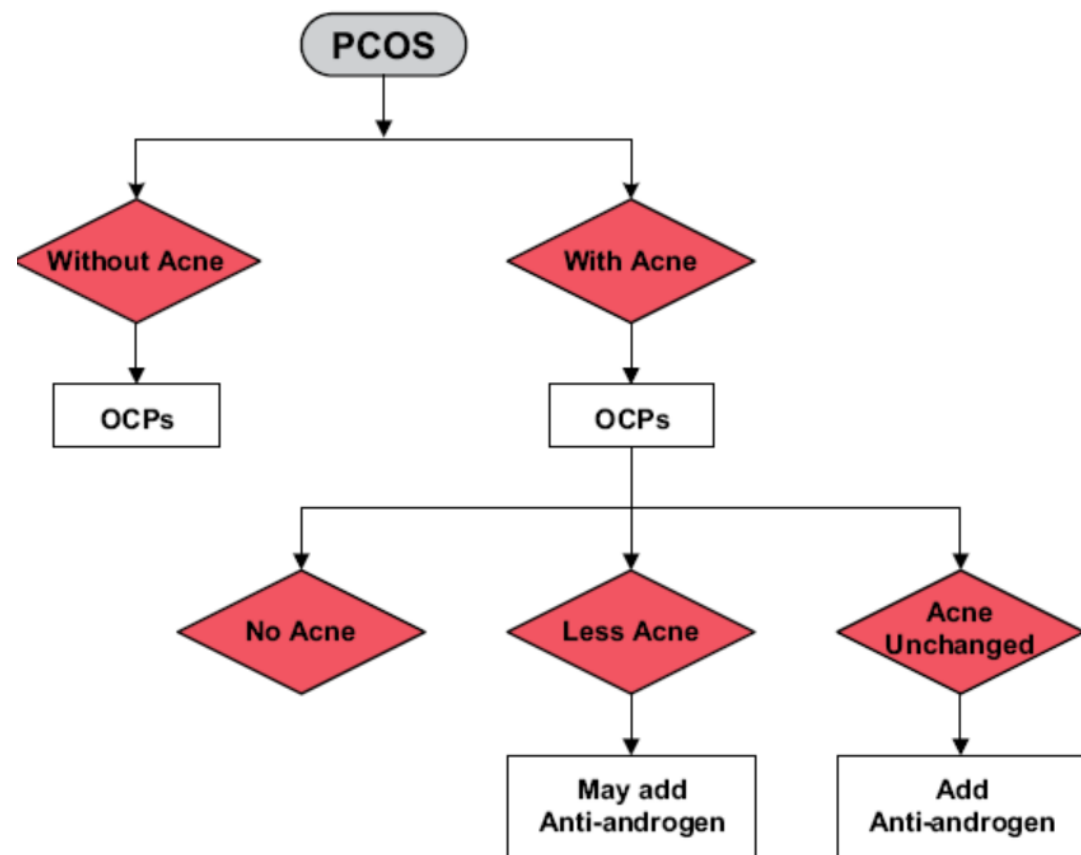
Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn của hội nội tiết Hoa Kỳ



- **OCPs** được sử dụng khi có nguy cơ cao hoặc chẩn đoán PCOS
- Khuyến cáo sử dụng **Ethinylestradiol <30ug**
- Sử dụng liệu pháp kháng androgen khi không điều trị OCPs và/hoặc liệu pháp thẩm mỹ **không đáp ứng sau 6 tháng**
- Liệu pháp kháng androgen
 - **Spironolacton 25-100mg/ngày**, ít tác dụng phụ
 - Cyproterone acetate với liều $\geq 10\text{mg}$ gây u màng não
 - Flutamide, finasteride với nguy cơ gây độc gan
- **Metformin**: khuyến cáo khi PCOS + BMI $\geq 25\text{kg/m}^2$ hoặc rối loạn lipid, đề kháng insulin, rối loạn glucose, bắt đầu liều thấp, tối đa 2g/thanh thiếu niên, 2,5g/người lớn



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày

26-07-2025

Thời gian

07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE

02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Isotretinoin trong PCOS

- Isotretinoin làm giảm mụn, testosterone tự do, insulin máu, thể tích buồng trứng và điểm rụng lông mà không cần dùng phối hợp thuốc tránh thai.
- Bệnh nhân PCOS có **nguy cơ tái phát mụn** (trong năm thứ hai sau điều trị isotretinoin) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với bệnh nhân không PCOS.
- Một số NC cho thấy **isotretinoin có thể bộc lộ các triệu chứng PCOS tiềm ẩn (vô kinh, rụng lông, kháng insulin)** ở người chưa chẩn đoán và có thể gây giảm dự trữ buồng trứng và gây chết tế bào hạt, ảnh hưởng đến sinh sản khi sử dụng lâu dài.
- isotretinoin trong điều trị **MTC/PCOS khi nặng, không đáp ứng với điều trị khác**

Acmaç G. *Biomed Res Int.* 2019;2019:2513067

Cakir GA. *Int J Dermatol.* 2013;52(3):371-376.

Pham T. *Endocr Pract.* 2007;13(7):776-779

Abdelhamed A. *Reprod Toxicol.* 2021;104:85-95



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày

26-07-2025

Thời gian

07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE

02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Mụn trứng cá ở phụ nữ trưởng thành Adult Female Acne



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Mụn trứng cá ở phụ nữ trưởng thành - AFA

- Tỷ lệ mắc mụn trên toàn thể giới ở phụ nữ mọi độ tuổi là khoảng 10%, phụ nữ trưởng thành khoảng 15–20% trong đó 20–30% các TH có biểu hiện rậm lông
- Định nghĩa: mụn trứng cá ở phụ nữ trưởng thành (AFA) được định nghĩa là một bệnh viêm mạn tính của nang lông - tuyến bã, phân bố chủ yếu ở **phần ba dưới của khuôn mặt**, xuất hiện đặc biệt ở **phụ nữ trên 25 tuổi**.
- Tỷ lệ bị mụn ở phụ nữ (12–41%) đã gia tăng trong những thập kỷ gần đây, một phần do các yếu tố môi trường độc hại như tia cực tím, ô nhiễm và các yếu tố căng thẳng lối sống



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Mụn trứng cá ở phụ nữ trưởng thành - AFA

- Yếu tố liên quan: cường androgen hoặc nhạy thụ thể androgen là nguyên nhân chính, tính chất di truyền (80%), kết hợp PCOS và rối loạn nội tiết, chuyển hóa phức tạp.
- Thể lâm sàng:
 - ❖ Thể viêm (58%)
 - ❖ Thể tiết bã (retention form)
- Tiến triển với 3 kiểu: mụn dai dẳng (phổ biến nhất), mụn khởi phát muộn (>25 tuổi), mụn tái phát



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00

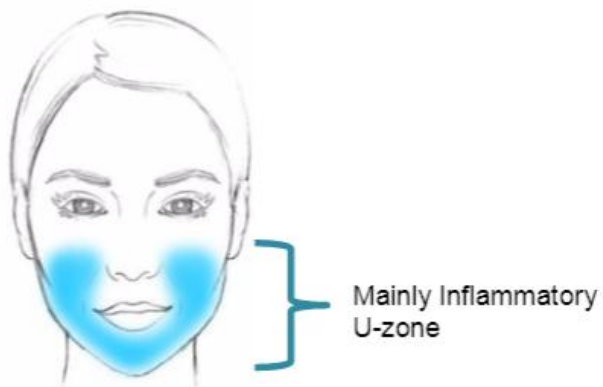


Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

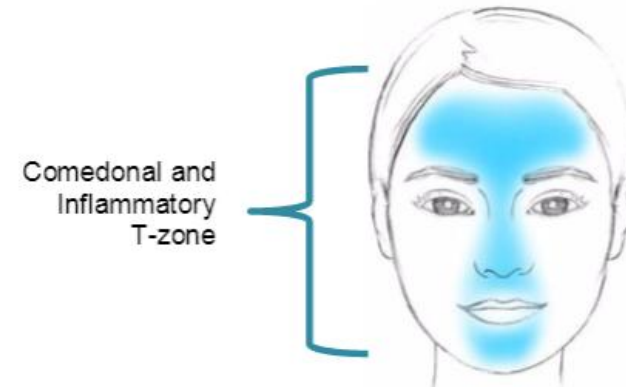
Mụn trứng cá ở phụ nữ trưởng thành - AFA

Regarding to	Adult female acne	Adolescent acne
Location in face	Diffuse or lower third face U-zone	Forehead T-zone: * Chin * Nose
Seborrhea	Present in 70%	Present in all patients
Skin sensibility	+++	+
Comedones	Few or absent	Always present
Inflammatory lesions	Papules, pustules, small nodules, rare cysts	Papules, pustules, nodules, cysts, abscesses
Intensity	Mild or moderate	Mild, moderate, or severe
Duration	Very long	Limited until 18–25 years
Response	Begins after 3 months of therapy	Respond quickly
Topical treatment	Less irritating options are better, such as * Adapalene 0,1%, azelaic acid 15%, and benzoyl peroxide 2,5%	All anti-acne options may be prescribed
Oral treatment		
* Antibiotics	Less recommended	Recommended to treat moderate to severe cases
* Hormonal treatment (female patients)	Very recommended	May be recommended

Adult



Adolescent



Bagatin E.. Treatment challenges in adult female acne and future directions. *Expert Rev Clin Pharmacol*. 2021;14(6):687-701.



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk





Thuốc thoa tại chỗ trong điều trị AFA

Retinoids + BPO

Retinoids: adapalene 0.1-0,3%, tretinoin 0,025-0,05%, trifaroten 0,005%

→ Clascoterone 1%, estradiol 0.05% peel-off mask

Azelaic acid 15 - 20%

Làm sạch + thuốc thoa + chống nắng

Kết hợp chống lão hóa + trị mụn

Amuzescu A. *Cosmetics*. 2024; 11(3):74

Falla, T. *International Journal of Women's Dermatology*, 6 (2020): 419 - 423.

El-Komy, M. *Clinical and experimental dermatology*. 2023



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Điều trị AFA

Global Alliance Acne Treatment Algorithm²²

	Mild comedonal	Mild mixed and papular/pustular	Moderate mixed and papular/pustular	Moderate nodular	Severe nodular conglobate
1st Choice	Topical retinoid	Topical retinoid + topical antimicrobial	Oral antibiotic + topical retinoid ± BPO	Oral antibiotic + topical retinoid + BPO	Oral isotretinoin
Alternatives for females	–	–	Oral anti-androgen + topical retinoid/azelaic acid ± topical antimicrobial	Oral anti-androgen + topical retinoid/ ± oral antibiotic ± alternative antimicrobial	High dose oral anti-androgen + topical retinoid ± alternative topical antimicrobial

European Dermatology Forum²⁹

	Comedonal acne	Mild-to-moderate papulopustular acne	Severe papulopustular/ moderate nodular acne	Severe nodular/ conglobate acne
High strength of recommendation	–	Adapalene + BPO BPO + clindamycin	Isotretinoin	Isotretinoin
Alternatives for females	–	–	Hormonal anti-androgens + topical treatment Or Hormonal anti-androgens + systemic antibiotics	Hormonal anti-androgens + systemic antibiotics



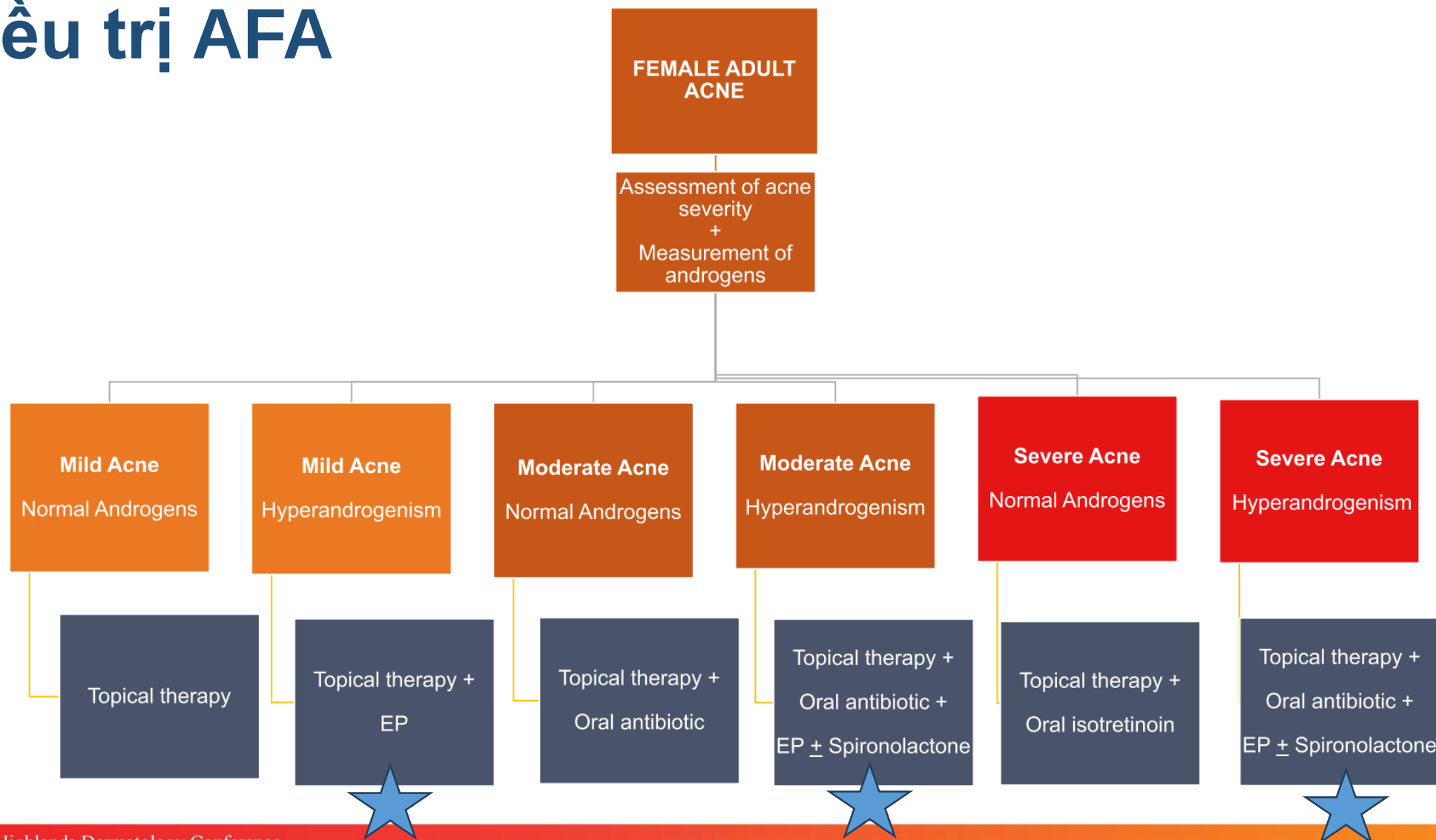
Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Điều trị AFA



Adult Female Acne: Recent Advances in Pathophysiology and Therapeutic Approaches

Andreea Amuzescu ^{1,2}, Mircea Tampa ^{1,2} , Clara Matei ^{2,*} and Simona Roxana Georgescu ^{1,2}

¹ Department of Dermatology, “Victor Babes” Clinical Hospital of Infectious Diseases, 030303 Bucharest, Romania; amuzescuandreea@gmail.com (A.A.); dermatology.mt@gmail.com (M.T.); srg.dermatology@gmail.com (S.R.G.)

² Department of Dermatology, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, 020021 Bucharest, Romania

* Correspondence: dermatology.cm@yahoo.com

Abstract: Adult acne is a chronic inflammatory disease of the pilosebaceous unit characterized by the excessive production of abnormal sebum favoring an imbalance of the skin microbiota and the hyperproliferation of *Cutibacterium acnes* and other virulent microbial strains, leading to an inflammatory environment, innate immunity overactivation, and keratinocyte hyperproliferation in hair follicles pores. Degraded keratinocytes plug the pores, consequently forming microcomedons, which can later evolve to papules, nodules, pustules and scars. Distinct from juvenile acne, in adult female acne (AFA) the symptomatology occurs or persists in postadolescence (after age 25). Although hyperandrogenism or the excessive sensitivity of androgen receptors are the main causes, AFA can be triggered by multiple factors, either including or not including androgen disturbances. The prevalence in adult women is 15–20%. Hyperandrogenism is present in 50% of cases; 70% of hyperandrogenism cases feature polycystic ovary syndrome (PCOS), a complex endocrine and metabolic condition. Genetic susceptibility occurs in 80% of acne cases, often with familial inheritance. Beyond classical stepwise therapeutic protocols (topical agents, isotretinoin, antibiotics, hormonal therapy with estrogens, progestins, spironolactone), novel approaches include the highly effective topical antiandrogen clascoterone, the management of insulin resistance by diet, exercise, stress avoidance, and adjuvant therapies such as berberine. Vaccines against the pathogenic proinflammatory *C. acnes* hyaluronidase A are in development.

Keywords: adult female acne; hormonal acne; hyperandrogenism; polycystic ovary syndrome; insulin resistance; genetic studies; antiandrogens

1. Introduction

Considering the increasing number of acne cases after puberty, this pathology cannot be considered a disease of adolescence anymore, as it significantly affects sufferer’s quality of life, possibly leading to depression and social anxiety [1].

The worldwide occurrence of acne among women across all age brackets stands at approximately 10% [2,3], with large variations across age groups [4]. Among adult women, the prevalence of acne ranges from 15 to 20% [5], with 20 to 30% of these cases exhibiting hirsutism [6], while a proportion varying between 18 and 88% demonstrate elevated androgen levels [7]. This suggests that the primary etiological factor lies in either heightened androgen secretion or the increased sensitivity of androgen receptors [8].

The majority of authors define acne as a chronic inflammatory illness affecting the pilosebaceous gland, resulting in increased sebum production. Although patients have a polymorphic clinical picture similar to *acne vulgaris*, adult female acne (AFA), also named postadolescent acne or hormonal acne, is defined as a chronic inflammatory disease of the pilo-sebaceous follicle predominantly distributed in the lower third of the face, appearing especially in adult women over 25 years of age [9].



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 -17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

- AFA là một bệnh **mạn tính, viêm và dễ tái phát**, có cơ chế bệnh sinh phức tạp và khác biệt đáng kể so với mụn ở tuổi dậy thì.
- **Androgen** đóng vai trò quan trọng, nhưng các yếu tố **nội tiết, di truyền, chuyển hóa (như đề kháng insulin)** và **yếu tố vi sinh vật** cũng góp phần vào cơ chế bệnh sinh.
- **Điều trị AFA** cần một cách tiếp cận **đa yếu tố và cá thể hóa**, kết hợp các liệu pháp tác động vào **bã nhờn, viêm, sừng hóa lỗ chân lông, C. acnes** và **yếu tố nội tiết**.
- Ngoài các phương pháp truyền thống (retinoids, benzoyl peroxide, kháng sinh, liệu pháp nội tiết, isotretinoin), những liệu pháp mới nổi – đặc biệt là **clascoterone** (kháng androgen tại chỗ), **berberine** (cải thiện đề kháng insulin) và **vaccine chống C. acnes** – đang mở ra hướng điều trị tiềm năng trong tương lai.



Citation: Amuzescu, A.; Tampa, M.; Matei, C.; Georgescu, S.R. Adult Female Acne: Recent Advances in Pathophysiology and Therapeutic Approaches. *Cosmetics* **2024**, *11*, 74. <https://doi.org/10.3390/cosmetics11030074>

Academic Editor: Enzo Berardesca

Received: 19 March 2024

Revised: 12 April 2024

Accepted: 1 May 2024

Published: 5 May 2024



Copyright: © 2024 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00

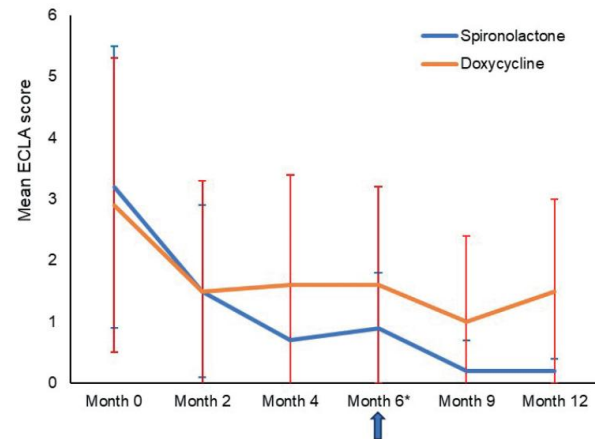
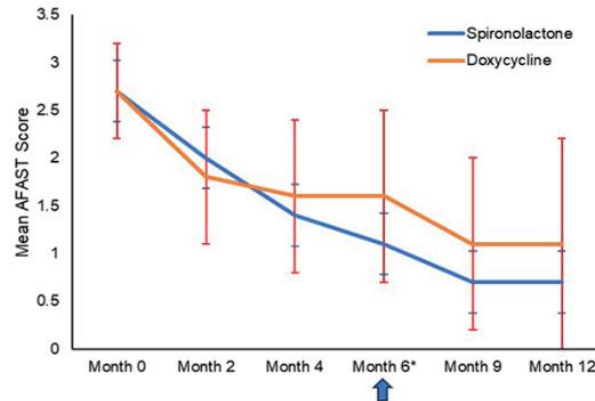


Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

ActaDV ACTA DERMATO-
VENEREOLOGICA

Acta Derm Venereol. 2024 Feb 21;104:26002. doi: [10.2340/actadv.v104.26002](https://doi.org/10.2340/actadv.v104.26002)

Efficacy of Spironolactone Compared with Doxycycline in Moderate Acne in Adult Females: Results of the Multicentre, Controlled, Randomized, Double-blind Prospective and Parallel Female Acne Spironolactone vs doxyCycline Efficacy (FASCE) Study



- NC đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi, song song so sánh hiệu quả và độ dung nạp của spironolactone và doxycycline trong điều trị MCT trung bình AFA
- 133 phụ nữ phân ngẫu nhiên:
 - (1) Doxycyclin + BPO 5%/ 3 tháng sau đó giả dược + BPO/3 tháng
 - (2) Spironolacton 150mg/ngày + BPO 5% trong 6 tháng liên tục
- Kết quả:
 - Spironolacton điều trị thành công gấp 3 lần doxycycline tại tháng thứ 6 ($p=0,0013$)**
 - Cải thiện mụn viêm, mụn không viêm, chất lượng cuộc sống
 - Tác dụng phụ spironolactone nhiều hơn nhưng chủ yếu nhẹ-trung bình: **rối loạn kinh nguyệt, chảy máu âm đạo, đau bụng trên, không có TH tăng kali huyết.**
- ➔ Spironolacton là lựa chọn an toàn và hiệu quả trong điều trị AFA



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



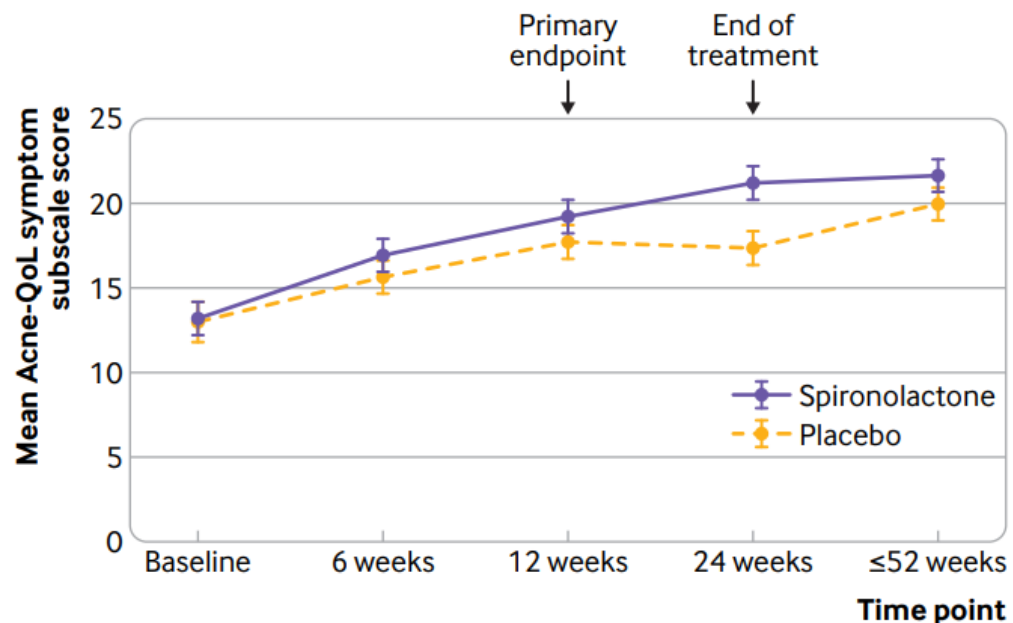
Ngày
26-07-2025

Thời gian
07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE
02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Spironolactone



thebmj Visual abstract



Spironolactone for women with acne

Summary



Acne improved more with spironolactone than with placebo, as measured by Acne-QoL* symptom subscale score at 12 weeks, with greater differences at 24 weeks. Secondary outcomes similarly favoured spironolactone, with greater differences at 24 weeks than 12 weeks

Study design



Randomised controlled trial



Double blind

All participants had acne severity judged to warrant oral antibiotics

Population



410 women aged ≥18 years with facial acne for at least 6 months

Mean age: 29.2 years

Completed trial: 342

Comparison

Control

Placebo

Matched to intervention

166

Intervention

Spironolactone

50 mg/day until week 6
100 mg/day until week 24

176



Outcomes

Intervention v control, mean score

Acne-Specific Quality of Life* PRIMARY

12 weeks

17.8

Adjusted mean difference 95% CI

19.2

24 weeks

17.4

21.2

Trial powered to detect a score difference of 2

Intervention v control, number improved

Investigator's global assessment at 12 weeks

6%

Adjusted odds ratio 95% CI

19%

Participant self-assessed improvement

12 weeks

68%

72%

24 weeks

63%

82%

<https://bit.ly/BMJacnesp>

*Acne-Specific Quality of Life
Range: 0-30, higher scores are better

© 2023 BMJ Publishing Group Ltd



HỘI NGHỊ DA LIỄU MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 28 - NĂM 2025



Ngày

26-07-2025

Thời gian

07:00 - 17:00



Khách sạn TUI BLUE

02 Hải Dương - Phường Tuy Hòa - Tỉnh Đắk Lắk

Kết luận

- Một số rối loạn nội tiết có triệu chứng mụn trứng cá như PCOS, AFA cần tầm soát toàn diện và điều trị phối hợp liên chuyên khoa.
- Thuốc tránh thai phối hợp, spironolactone là những thuốc được ưu tiên hơn trong phối hợp điều trị ở bệnh nhân mụn có triệu chứng cường androgen
- Cần theo dõi các hoocmon liên quan trong quá trình điều trị.



THANK YOU

